

11 - 09- Troubles psychiatriques chez les patients épileptiques - Pr. ADALI

J'ai laissé 30 minutes aux questions que vous avez. Troubles psychiques de l'épilepsie. On y va.

Les troubles psychiatriques chez les patients épileptiques, s'il vous plaît. Pourquoi on a insisté sur... Pourquoi ce chapitre est important ? Déjà, la présence de troubles psychiatriques dans l'épilepsie. Déjà, qu'il y ait des troubles psychiatriques dans l'épilepsie.

Ça, il faut le savoir. Les troubles psychiatriques dans l'épilepsie sont un facteur de mauvais pronostic pour l'épilepsie. Ce sont des troubles qui ne se stabilisent pas, les neuroleptiques, pardon, mais plutôt qui se stabilisent par la stabilisation de l'épilepsie en elle-même.

L'épilepsie, les troubles psychiatriques. On va expliquer comment. Il y a trois types de troubles.

Et ça, je poserai des questions au fur et à mesure. Je poserai des questions à la fin de la session. Il y a ce qu'on appelle des troubles psychiatriques de la crise épileptique.

Il y a la crise qui fait partie de la crise. C'est une crise sous forme de troubles psychiatriques qu'on appelle troubles psychiatriques critiques. Critique, ça vient de crise.

Qui font partie soit de la crise, soit de ses suites immédiates. Quand je dis suites immédiates, c'est-à-dire quelques heures, quelques minutes après la crise tonico-clonique généralisée, les crises l'équilibre justement. Là, ils font partie de la crise en elle-même.

Il y a des troubles psychiatriques intercritiques, c'est-à-dire entre les crises. Et il y a des troubles psychiatriques secondaires à l'atteinte cérébrale responsable de l'épilepsie. On ne va pas le voir en détail.

Ce qui nous intéresse, c'est les deux premières rubriques. Par exemple, quand vous avez une tumeur temporale qui va en même temps causer des crises épileptiques de type temporale et en même temps causer une symptomatologie psychiatrique parce qu'au niveau temporal, au niveau frontal, l'atteinte temporale au frontal peut entraîner des troubles psychiatriques. Manifestation critique, ça peut être des symptômes prodromiques.

Dans la crise, le patient peut présenter instabilité, dysphorie. Les troubles liés à la crise, proprement dit, c'est des automatismes psychomoteurs. C'est des gestes automatiques que fait le patient et qui peuvent être interprétés de travers.

Par exemple, une personne qui est en train de se déshabiller, c'est comme si c'était mécanique, c'est comme si c'était un robot qui était en train de se déshabiller. Ça peut être considéré, mal compris par les autres, ou dangereux à type de fugue, de conduite automobile. Je crois que je vous ai donné l'exemple de cette personne-là qui a conduit sa voiture sans s'arrêter, alors qu'il était au bon milieu de sa crise épileptique.

Le risque, les troubles liés à la crise, c'est qu'il y a le risque de passage à l'acte auto, mais surtout hétéroagressif. Il faut savoir qu'une bonne partie des patients médico-légaux qui étaient hospitalisés, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais quand j'étais résidente, une bonne partie des patients médico-légaux qui étaient hospitalisés dans notre hôpital étaient des patients épileptiques qui avaient des troubles du comportement, des troubles psychiatriques. Ce n'était pas des schizophrènes, ce n'était pas des bipolaires, mais c'était des patients épileptiques.

Les actes médico-légaux que peuvent faire des patients épileptiques sont très graves, sont très dangereux. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais quel est le type d'agitation le plus intense à votre avis ? Qui sont les patients les plus agités ? Qui sont passés par le service ? C'est les schizophrènes ? Les bipolaires ? Les épileptiques ? C'est les patients épileptiques. La première agitation en termes d'intensité, c'est la fureur, qu'on appelle fureur épileptique, qui change extrêmement la fureur.

C'est les patients épileptiques en premier. J'ai déjà vu un patient épileptique, il était dans l'hôpital, j'étais de garde. J'ai allé à la salle de garde, et j'ai vu un patient épileptique qui se moquait de moi.

Je vous assure, il se moquait de moi. C'était le patient agité qui était menotté dans une des salles de garde. Il était menotté par l'agitation.

C'était l'extrême agitation. Il y a les automatismes moteurs, qui sont les troubles de la conscience. C'est normal, vous le connaissez, vous le savez mieux que moi, parce que c'est des crises épileptiques où vous pouvez trouver un syndrome confusionnel, une baisse de la vigilance.

Des états crépusculaires, c'est aussi une baisse de la vigilance, et surtout une symptomatologie hallucinatoire multiple, surtout dans l'épilepsie temporale. C'est ça en fait ce qui cause beaucoup de confusion quand on reçoit des patients, parce que c'est typiquement chacun. On vous ramène un patient seul, par la police extrêmement agité, vous voyez qu'il est halluciné, des propos incohérents, délirants, impossible d'avoir un contact mère.

On a zéro information sur ses antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques, et là, aller le traiter, aller le calmer. Dans beaucoup de situations, on est tombé sur des patients épileptiques, connus épileptiques, ils ont fait leur crise dehors, on ne peut même pas détecter un syndrome confusionnel chez ces patients, tellement ils sont agités, tellement il n'y a aucun contact avec eux. Donc on est passé à côté d'agitations post-critiques chez des patients épileptiques.

Ce n'est que le lendemain, quand les patients se calment, qu'on peut avoir des informations concernant l'origine de cette symptomatologie. Les manifestations, on parle de manifestations critiques, mais ce sont des manifestations post-critiques, c'est-à-dire dans les médias, on est toujours dans la crise, les états confusionnels, l'automatisme psychomoteur, et surtout les

troubles du comportement, type fureur agressive, fugue, voyage pathologique, grande agitation psychomotrice. C'est ce que j'ai trouvé.

C'est ce que j'ai trouvé. Oui. A bon entendeur, ces troubles, comment les caractériser ? Parce qu'ils ont un début et une fin brusques, comme la crise.

Ils ont les mêmes caractéristiques d'une crise épileptique tonico-clonique généralisée, c'est-à-dire un début brusque et une fin brusque. Il y a de durées brèves associées à des troubles de la vigilance avec une amnésie post-critique. Le patient est agité, il y a des problèmes d'esprit, il y a des problèmes d'esprit.

Puis, à postériori, quand les symptômes s'atténuent, il n'y a rien. Le patient ne se rappelle de rien du tout. Donc, l'amnésie post-critique est présente.

Et il y a une récurrence sur le même pote, c'est-à-dire dans la crise d'elle ou sous forme de je ne sais pas moi. Une agitation avec automatisme X, la crise va toujours récidiver sous la même forme. By the way, il se peut qu'à 100%, je ne pose pas de questions sur les troubles psychosomatiques.

Ça fait. Ça, c'est un bonus pour les gens qui étaient sérieux, qui assistaient au cours. Ça fait.

Les troubles psychiatriques, s'il vous plaît, intercritiques. Intercritiques, c'est généralement des troubles qui sont chroniques. Sont retrouvés de temps 30 à 60% des cas.

Chez la durée, on va voir. Surtout, c'est des troubles intellectuels. Savoir que beaucoup de patients épileptiques, surtout contre l'épilepsie, survient à l'enfance.

Ils ont des déficiences intellectuelles. C'est noté chez environ 10% des patients épileptiques. D'ailleurs, je ne vous montrerai pas.

Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ça peut être sous forme de troubles du comportement.

C'est des personnes qui sont toujours coléreuses, agitées. Ils sont impulsifs par définition, peuvent avoir des conduites hétéro-agressives ou auto-agressives. À chaque fois que je fais le cours des troubles psychiatriques et épilepsies, je me rappelle d'un patient.

Je n'arrive pas à l'oublier. C'était un patient aussi qui faisait des... Au début, c'est une épilepsie qui est survenue depuis l'enfance. Au début, c'était juste des troubles toniques ou cloniques généralisés.

C'est un patient qui ne se stabilisait pas malgré l'observance du traitement. C'était une épilepsie réfractaire. Et puis, vers le 20e siècle, il a commencé à présenter des troubles du comportement, surtout intercritiques.

C'était un patient qui se poignardait, qui faisait beaucoup de tentatives de suicide, extrêmement impulsif, difficilement stabilisé, toujours hospitalisé en psychiatrie. Il est décédé

par quoi ? Votre avis ? Vous savez que parmi les... C'est une complication rare, mais sérieuse. Il était hospitalisé.

J'étais en résidence. Il était hospitalisé encore une fois. Donc, normal, nickel, sans problème, bien sûr.

Sur le plan organique, je veux dire. Je suis partie en congé pour une dizaine de jours. Quand je suis rentrée, on m'avait dit qu'il était décédé.

Il avait présenté un syndrome maladie au cours de l'hospitalisation. Hospitalisé en réanimation, ils n'ont pas pu le sauver. Donc, tellement... Et en même temps, pour chaque symptôme, je me rappelle de mon malade.

C'était des troubles vraiment typiques. Dans les troubles intercritiques, il y a la fréquence aussi de la symptomatologie anxio-dépressive, surtout la dépression. Le souci dans la dépression chez le patient épileptique, c'est que c'est une symptomatologie dépressive qui est atypique.

On ne va pas trouver tout le temps l'humeur dépressive, l'épisode dépressif majeur que vous connaissez, mais plutôt un trouble dysphorique de l'anxiété, de l'irritabilité associée à l'humeur dépressive. Et une fluctuation aussi de la symptomatologie dépressive. Elle est fluctuante, mais pas constante comme l'épisode dépressif majeur.

Fluctuante. C'est une symptomatologie... C'est très difficile de diagnostiquer un patient épileptique de dépression. Deuxième difficulté dans la dépression chez le patient épileptique, c'est le traitement.

Il faut savoir que tous les antidépresseurs, ils diminuent le seuil épileptogène. Donc le risque de faire des crises épileptiques, il est important quand on introduit des antidépresseurs. Il faudrait qu'il y ait une coordination avec le neurologue pour qu'il augmente le traitement, pour couvrir la durée du traitement antidépresseur.

L'anxiété aussi, des attaques de panique. Il y a aussi la fréquence des troubles psychotiques. Surtout ce qu'on appelle la psychose ictale.

La psychose ictale, c'est un trouble typique de l'épilepsie. C'est un trouble typique qui survient quand on a un état de mal épileptique. Si vous avez un patient qui fait des crises rapprochées, un état de mal, il peut présenter une psychose ictale.

C'est le cas typique dont je vous ai parlé, de patients qui s'y sont ramenés, qui agitaient après qu'ils aient fait plusieurs crises épileptiques. Mon patient-là, il était toujours en état de mal. Toujours.

C'était pour les neurologues, c'était un bon suivi chez le neurologue. Il n'y avait zéro critique ou commentaire par rapport à la conduite des neurologues. Mais même pour eux, c'était une épilepsie réfractaire.

Mais eux, ils ne savaient pas trop comment gérer. Il y a aussi la manie post-ictale, c'est-à-dire que la symptomatologie qui va survenir juste après la crise peut être sous forme de syndrome maniaque. Typiquement, comme le syndrome maniaque, sauf que ça va survenir après la crise épileptique.

Les troubles psychotiques intercritiques peuvent être aigus, il y a la psychose ictale, ou chroniques. C'est-à-dire qu'entre les crises, de façon chronique, qu'il y ait une symptomatologie psychotique, délirante, avec des hallucinations, ça peut aussi mimer une symptomatologie schizophrénique. Un trouble de la personnalité, généralement les personnes épileptiques sont des personnes qui sont dépendantes, immatures, parfois des traits antisociaux.

Chez l'enfant, je passerai, ça c'est l'handicap chez le patient épileptique, handicap sociétal, je passerai rapidement. Ce qui est important pour nous, pour vous en tant que médecins généralistes, la dépression, j'en ai déjà parlé. Patients épileptiques déprimés, antidépresseurs, privilégiez les nouveaux antidépresseurs, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine.

Et aussi coordonner avec le neurologue pour augmenter la dose de traitement. Psychose ictale et post-ictale, les neuroleptiques antiproductifs, les antipsychotiques, là encore, les antipsychotiques, ils diminuent le seuil épileptogène. Donc, un traitement neuroleptique, ou l'antidépresseur chez un patient épileptique, augmentez la dose du traitement antiépileptique pour couvrir.

Parce que le risque, c'est que le patient va vous faire un état de mal. L'anxiété, privilégiez les anxiolytiques, qui ont aussi une action anticonvulsivante. Le traitement de choix, quand vous avez une anxiété chez un patient épileptique, c'est le Valium.

Le Valium, il a une action anticonvulsivante qui est assez forte. Les antiépileptiques, il faut savoir que les antiépileptiques aussi peuvent entraîner des troubles psychiatriques. Là, c'est l'incidence, excusez-moi, c'est l'incidence des troubles psychiatriques, des crises, pardon, épileptiques, après l'introduction de psychotrape.

Regardez pour les antidépresseurs tricycliques, les anciens, c'est entre 0,1 et 4. D'accord ? Regardez pour la sertraline, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, un IRS, c'est inférieur à 0,1. Pour le citalopram, qui est aussi un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, un nouveau antidépresseur, l'incidence est entre 0,1 et 0,3. D'accord ? Voilà.

Ça, c'est un tableau qui montre certains effets secondaires psychiatriques de certains traitements antiépileptiques, comme la motrigine peut entraîner une insomnie, agitation. Je ne poserai pas de questions sur ça. En tout honnêteté, c'est l'inégalité.